TEMA 29 · Cuidados de enfermería en la infancia. Higiene y salud bucodental, alimentación, prevención de accidentes y malos tratos, y vacunación

Resumen OPE Enfermería SMS · Valoración del niño (escalas, crecimiento, desarrollo), PADI y flúor, higiene y sueño, lactancia y alimentación complementaria, accidentes y sistemas de retención, maltrato infantil y protocolo de Murcia, vacunación y hábitos saludables

1. Valoración del niño

- Repaso neonatal (ver Tema 28): pérdidas de calor (al nacer **evaporación**, después **radiación**), **vitamina K 1 mg IM en el vasto externo**, pomada de **eritromicina**, **prueba del talón a las 48-72 h**. **Apgar** (más puntos, mejor) y **Silverman** (0 = sin dificultad). **Capurro** (204 + puntos ÷ 7) en el RN a término; **Ballard** en prematuros extremos.
- **Antropometría**: pérdida de hasta el **10%** del peso los primeros días, recuperado hacia el **10.º-14.º día**; **duplica el peso a los 5 meses** y lo **triplica al año**; talla al nacer ≈ 50 cm, **+50% el primer año** (≈ 75 cm); perímetro cefálico al nacer 34-35 cm.
- **Percentiles**: un **percentil 3 aislado no es patológico**; lo que alarma es **cruzar percentiles** en controles sucesivos o la caída de la **velocidad de crecimiento** (cm/año: el indicador más sensible).
- **Desarrollo psicomotor**: **Haizea-Llevant** y **Denver II** (**no mide inteligencia**, sino maduración; 4 áreas: **personal-social, motor fino-adaptativa, lenguaje y motor grueso**).

Hito	Edad habitual	Señal de alarma
Sonrisa social	1-2 meses	Sin contacto visual a los 3 meses
Sostén cefálico	2-3 meses	No lo tiene a los **4 meses**
Sedestación sin apoyo	6-7 meses	No a los **9 meses**
Gateo (puede faltar)	8-10 meses	Asimetría
Bipedestación	10-12 meses	No a los 15 meses
Marcha autónoma	12-15 meses	**No camina a los 18 meses**
Primeras palabras	10-12 meses	Sin lenguaje a los 18 meses

- **Reflejos**: un **Moro** que persiste a los **6-7 meses** es signo de alarma. **Babinski** (extensión del dedo gordo) es **normal hasta los 18-24 meses** (mielinización de la vía piramidal).
- Constantes: FC del RN 120-160 lpm y del lactante 100-120; FR del RN 40-60 rpm y 30-40 en el primer año. Fontanela **posterior** (triangular) se cierra a los **2-3 meses**; **anterior** (romboidal) a los **12-18 meses**; **abombada** = hipertensión intracraneal; **hundida** = deshidratación.
- **Dentición**: primer diente (**incisivo central inferior**) a los **6-8 meses**; si no ha salido ninguno a los **12-14 meses**, estudiar (hipotiroidismo, raquitismo). Orden: incisivos → primeros molares → caninos → segundos molares.

2. Salud bucodental

- La **caries** es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia.
- **PADI de Murcia**: con **tarjeta sanitaria del SMS**, desde los **6 años** (dentición definitiva) hasta la adolescencia; libre elección de dentista público o privado adherido ("dentista de cabecera"). Ampliación para niños con discapacidad (sedación o anestesia general).

Incluido	Excluido
Revisión anual, educación (cepillado, seda, dieta)	**Ortodoncia**
Flúor tópico en alto riesgo y **sellado de fisuras** de molares permanentes	**Obturaciones (empastes) en dientes temporales**
Tartrectomía y radiografías	Tratamientos estéticos
Obturaciones y endodoncias en dientes permanentes	

Incluido	Excluido
Extracciones (temporales y permanentes) y traumatismos	

- **Flúor**: forma **fluorapatita** (esmalte más resistente al ácido de *Streptococcus mutans*). El exceso sistémico durante la formación del esmalte produce **fluorosis** (manchas blancas).

Edad	Pasta	Cantidad
Desde el primer diente hasta los 2 años	**1.000 ppm**	Mínima (grano de arroz)
2-6 años	1.000-1.450 ppm	**Guisante**
> 6 años	**1.450 ppm**	1-2 cm

- Cepillado **supervisado hasta los 8 años**; el **nocturno es el más importante** (menos saliva); **escupir sin enjuagar** con agua.

3. Higiene, sueño y alimentación

- **Cordón**: cura en seco; los antisépticos retrasan la caída (7-14 días). **Piel**: jabones **syndet** de pH ≈ 5,5. **Dermatitis del pañal**: cambios frecuentes, limpiar con agua, airear; **talco contraindicado** (neumonitis por inhalación).
- **SMSL** (primera causa de muerte posneonatal): **boca arriba**; colchón firme; cuna sin almohadas (hasta los 2 años), peluches ni chichoneras; **habitación a 20-22 °C** sin sobreabrigo. **Colecho contraindicado** si los padres **fuman** (aunque no sea en la habitación), han tomado alcohol, drogas o psicofármacos, si el bebé es **prematuro o de bajo peso**, o en **sofás**. **Plagiocefalia**: alternar la posición de la cabeza y **tiempo boca abajo despierto y vigilado** (*tummy time*).
- **Lactancia materna exclusiva y a demanda 6 meses**; complementada hasta los **2 años** o más.
- **Calostro** (3-5 primeros días): amarillo, **IgA secretora**, lactoferrina: «primera vacuna»; ayuda a expulsar el meconio. **Transición**: días 5-14. **Madura**: desde el día 15; **87% agua**, **lactosa**, proteínas del suero (**alfa-lactoalbúmina**), grasas = 50% de la energía.
- **Al final de la toma la leche tiene más grasa** (saciedad): no retirar al niño por reloj.
- **Contraindicaciones reales**: **VIH** (en países desarrollados), **HTLV I/II**, **galactosemia** del niño, drogas de abuso, antineoplásicos y radiofármacos.
- **Alimentación complementaria**: **a los 6 meses** (nunca antes de los 4); retrasarla da **déficit de hierro** (las reservas se agotan a los 6 meses). Alimentos **de uno en uno cada 3-5 días**; texturas progresivas; *baby-led weaning* con trozos que el niño agarra.
- **Gluten** entre los **4 y 11 meses**, en pequeñas cantidades. **Alérgenos** (huevo, pescado, cacahuete triturado) **sin retrasar**: inducen tolerancia.
- **Prohibidos el primer año**: **leche de vaca entera** (sobrecarga renal y anemia ferropénica), **miel** (**botulismo**), **espinacas y acelgas** (**nitratos** → **metahemoglobinemia**, no por alergia), **sal y azúcar** añadidos. **Frutos secos enteros, uvas o salchichas en rodajas**: no antes de los **5 años** (asfixia).

4. Prevención de accidentes

- Las lesiones no intencionadas son la **primera causa de muerte en niños mayores de 1 año**. En el **lactante**, la primera causa de muerte accidental es la **asfixia** (atragantamiento, sueño inseguro); a partir del año, el **tráfico**.

Edad	Riesgos	Prevención
0-6 meses	**Caídas del cambiador**, asfixia, quemaduras del baño	No dejarlo solo **ni un segundo**; comprobar el agua; dormir boca arriba
6-12 meses	**Atragantamiento** (todo a la boca), electrocución	Retirar objetos pequeños y **pilas de botón**; tapar enchufes; vallas en escaleras
1-4 años	**Intoxicaciones**, **ahogamientos**, caídas desde ventanas	Productos y fármacos **en alto y bajo llave** (no bajo el fregadero); vallar piscinas
5-14 años	**Tráfico** (peatón, bici), deportes	Educación vial, **casco**, sistemas de retención

- **Intoxicaciones** (más en **1-4 años**: cáusticos y fármacos): **nunca provocar el vómito** (vuelve a quemar el esófago y riesgo de aspiración) ni dar leche o agua: **llamar al Servicio de Información Toxicológica** y acudir al hospital **con el envase**.
- **Ahogamiento**: en pocos centímetros de agua y **en silencio**; vigilancia continua al alcance del brazo; los manguitos no sustituyen la vigilancia (chaleco homologado).
- **Quemaduras en niños**: superficie con la **tabla de Lund y Browder** (no la regla de los 9 de Wallace: en el lactante la cabeza supone ≈ 18-19%).
- **Sistemas de retención infantil (SRI)**:
- **R44/04** (venta prohibida desde **septiembre de 2024**; uso legal): **por peso**: grupo 0 (hasta 10 kg), **0+ (hasta 13 kg, a contramarcha)**, I (9-18 kg, arnés), II (15-25 kg) y III (22-36 kg, elevadores con cinturón).
- **R129 (i-Size)**: **por altura**; **contramarcha obligatoria hasta al menos los 15 meses** (recomendada hasta los 4 años); **ISOFIX**; pruebas de **impacto lateral**.
- Obligatorio SRI si la estatura es **≤ 135 cm**; entre **135 y 150 cm**, SRI o cinturón (mejor el SRI). Viajar **detrás**; delante solo por excepción (coche sin asientos traseros, traseros ocupados por otros menores o sin espacio para instalarlos). **A contramarcha delante: airbag desactivado** (si no se puede, no puede viajar ahí).
- A contramarcha, el impacto lo absorbe el respaldo del SRI; a favor de la marcha, el **cuello** del niño.

5. Maltrato infantil

- **LOPIVI (Ley Orgánica 8/2021)**: los sanitarios tienen el **deber de comunicar** cualquier **sospecha** fundada, **sin necesidad de pruebas** ni certeza.
- **Negligencia**: la forma **más frecuente** (> 50% de las notificaciones): falta de alimentación, higiene, vacunas, citas médicas, escolarización.
- **Maltrato físico** (banderas rojas): lesiones **incompatibles con el desarrollo** (hematomas o fractura en un niño que no camina), explicaciones contradictorias, **retraso en consultar**, **quemaduras por inmersión «en guante o calcetín»** sin salpicaduras.
- **Niño zarandeado**: **hemorragia subdural + hemorragias retinianas + edema cerebral**, a menudo **sin lesiones externas**.
- **Violencia sexual**: ITS o embarazo, lesiones genitales/anales, **enuresis o encopresis secundarias**, conductas regresivas; atención a la sumisión química.
- **Maltrato emocional** (humillación, rechazo, aislamiento) y **trastorno facticio aplicado a otro (Münchausen por poderes)**: el cuidador **inventa o provoca** síntomas en el niño.
- **Protocolo de Murcia**: **Hoja de Notificación de Riesgo y Maltrato Infantil desde el Ámbito Sanitario** (alimenta el **RUMI**). Registrar **literalmente** lo que dice el niño, describir las lesiones con esquemas y las conductas **sin juicios de valor**; entrevistar al niño **a solas** si la edad lo permite; **no confrontar ni avisar antes a la familia**.

Situación	Actuación
Urgente (lesión grave, riesgo inminente)	Tratar; **parte de lesiones al Juzgado de Guardia**; avisar a **policía**; **ingreso de protección** (no entregar al niño a los presuntos agresores aunque los padres se opongan)
No urgente (negligencia, sospecha leve)	**Hoja de notificación → trabajador social sanitario → servicios sociales municipales** o entidad de protección

6. Vacunación infantil

- **Atenuadas** (vivas): **triple vírica, varicela, rotavirus**; contraindicadas en **inmunodepresión grave y embarazo**. **Inactivadas**: hexavalente, neumococo, meningococo, VPH, gripe inyectable; seguras en inmunodeprimidos.
- **Cadena de frío: +2 a +8 °C**; **la congelación inutiliza** las inactivadas con adyuvante de aluminio (desechar).
- **Vías**: **IM a 90°** (**vasto externo** en lactantes que no andan; **deltoides** desde los 18 meses-2 años); **SC a 45°** (triple vírica y varicela, que también admiten IM); **oral** (rotavirus).
- Dos **vivas parenterales** (triple vírica, varicela): **el mismo día o separadas ≥ 4 semanas**. Entre inactivadas **no hay intervalo mínimo**.

Edad	Calendario infantil de Murcia 2025-2026 (manual)
Embarazo	**Tdpa** (semanas 27-36), gripe y COVID-19
Nacimiento	Hijo de madre **HBsAg +**: vacuna **+ inmunoglobulina** de hepatitis B en 12 h. **Nirsevimab** en temporada
2 meses	**Hexavalente**, **neumococo 20-valente**, **MenB**, **rotavirus**
4 meses	Hexavalente, VNC20, MenB, **meningococo conjugado**, rotavirus
6 meses	Rotavirus (si es de 3 dosis)
11 meses	Hexavalente y VNC20 (recuerdo)
12 meses	**Triple vírica**, **MenB**
15 meses	**Varicela**
3-4 años	Triple vírica y varicela (2.ª dosis)
6 años	DTPa + polio inactivada
12 años	**MenACWY** y **VPH (chicos y chicas, dosis única)**
14 años	Tétanos-difteria (el manual indica Tdpa)

- **Hexavalente** (pauta **2 + 1: 2, 4 y 11 meses**): difteria, tétanos, tos ferina acelular, **polio inactivada**, **Hib** y **hepatitis B**.
- **VNC20** sustituye a la de 13 serotipos (2, 4 y 11 meses), con dosis de rescate para los vacunados con la 13-valente.
- **Rotavirus** (oral, viva; financiado para nacidos desde 2024): **primera dosis antes de las 12 semanas** (más tarde aumenta el riesgo de **invaginación intestinal**).
- **MenB** (Bexsero, proteínas recombinantes): **2, 4 y 12 meses**; muy **reactógena** (fiebre en 24 h; se usa paracetamol).
- **VRS: nirsevimab** es un **anticuerpo monoclonal** (**inmunidad pasiva**, no una vacuna): **una dosis IM** al inicio de la temporada o en la maternidad; dosis según el peso (corte en 5 kg).
- **VPH**: a los **12 años, chicas y chicos**; dosis única; rescate de varones jóvenes en Murcia.
- **Gripe**: lactantes y niños desde los **6 meses**; desde los **2 años** existe la **intranasal** (atenuada).

7. Hábitos saludables

- **Sol**: las quemaduras con ampollas en la infancia son el mayor factor de riesgo de **melanoma**. **< 6 meses: sin fotoprotector**, solo **sombra y barreras físicas** (ropa, gorro, gafas). **6 meses-3 años**: filtros **físicos** (dióxido de titanio, óxido de zinc). **> 3 años**: filtros químicos o mixtos, **30 min antes** y renovar **cada 2 h** y tras el baño.
- **Pantallas**: **< 2 años: cero** (salvo videollamadas con familiares); **2-5 años: máximo 1 hora al día**, contenidos de calidad y **acompañados**. Nunca como «chupete emocional» ni **durante las comidas** (anulan la percepción de saciedad: obesidad).
- **Actividad física (OMS)**: **≥ 60 minutos diarios** de intensidad **moderada a vigorosa** y actividades de **fortalecimiento muscular y óseo ≥ 3 días/semana**. El ejercicio del fin de semana **no compensa** el sedentarismo diario.
- **Ley de Wolff**: el hueso se fortalece con **impacto** (correr, saltar, deportes de equipo); **natación y ciclismo** apenas estimulan el hueso. Objetivo: alcanzar el **pico de masa ósea** al final de la adolescencia (prevención de la osteoporosis).

TRAMPAS DE EXAMEN

- ! El **percentil 3** aislado no es enfermedad; sí **cruzar percentiles**.
- ! PADI: **nunca ortodoncia ni empastes de dientes de leche** (de los temporales solo la extracción).
- ! Pasta con **1.000 ppm desde el primer diente**; escupir **sin enjuagar**.
- ! Espinacas y acelgas antes del año: riesgo de **metahemoglobinemia** (nitratos), no de alergia.
- ! Ingestión de cáusticos: **nunca provocar el vómito**; llamar a Toxicología.
- ! i-Size: **contramarcha mínimo 15 meses**; delante a contramarcha, **airbag desconectado**.
- ! Sospecha de maltrato: **comunicar** sin necesidad de pruebas y **sin avisar antes a la familia**.
- ! Nirsevimab es un **anticuerpo monoclonal** (inmunización pasiva), no una vacuna.
- ! Rotavirus: **primera dosis antes de las 12 semanas**.
- ! Menor de 6 meses: **ningún fotoprotector**, solo sombra y ropa.